



1ª JORNADA INCUBINTECH · DESAFIO SAÚDE DO MÉDICO

O médico cuida de todos. Quem cuida do médico?

Uma plataforma de triagem e suporte confidencial à saúde mental do médico — com IA de acolhimento, pares anônimos e privacidade construída desde a primeira linha de código.

57%

dos médicos brasileiros
com sintomas de
burnout (CFM/AMB,
2022)

<12%

buscam ajuda
profissional — o medo
de expor o registro no
CRM pesa mais que o
sofrimento



Não é falta de vontade. É falta de um canal seguro.

O médico em sofrimento psíquico não tem para onde ir sem medo de expor sua condição e prejudicar o próprio registro profissional. O resultado se paga em vidas — dos médicos e dos pacientes.

Erros clínicos evitáveis

Exaustão e sofrimento psíquico não tratados aumentam a chance de falhas em decisões clínicas de rotina.

Abandono precoce da profissão

Especialistas escassos deixam a carreira ou o plantão — um custo de recontração que hospitais sentem direto.

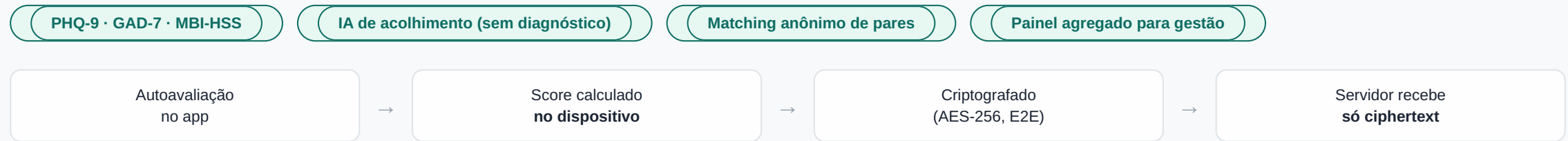
Risco de vida real

Taxas de suicídio entre médicos mais que o dobro da população geral — um dado que nenhuma instituição de saúde pode ignorar.

A SOLUÇÃO

Uma plataforma clínica, construída ao redor do sigilo

Autoavaliação validada, acolhimento por IA, pares anônimos e um painel que o hospital pode confiar — porque nunca vê o indivíduo.



O sigilo é a regra.

A quebra dele, quando existe, é sempre escolha do médico — nunca do sistema, nunca do empregador.



"O hospital paga pela ferramenta. Mas não vê o indivíduo — só recebe métricas agregadas e anônimas. Essa separação não é um detalhe técnico: é o produto."

- Score calculado no dispositivo, nunca em texto claro no servidor
- Acolhimento por IA e matching de pares totalmente anônimos

ESCALONAMENTO EM RISCO AGUDO

- Em sinal de risco, a IA **oferece** — não força — conexão com psicólogo parceiro
- Identidade exposta só nesse canal, nunca persistida



Quem paga não é quem julga

Hospitais e cooperativas médicas financiam a ferramenta como gestão de risco operacional — sem nunca ganhar acesso ao indivíduo.

QUEM PAGA	POR QUÊ	O QUE RECEBE
Hospitais, redes de saúde, cooperativas (ex: Unimed), sindicatos médicos	Erro clínico evitável, rotatividade e afastamento custam mais do que prevenção — mesma lógica de seguro de responsabilidade civil	Painel agregado e anônimo de tendências da equipe (ex: sinais de burnout por turno/setor), nunca dados individuais

Receita: SaaS B2B por médico ativo/mês, em tiers (básico vs. institucional com painel). **Entrada:** uso individual gratuito para o médico, o que gera adoção orgânica antes mesmo do hospital comprar.

De Santa Catarina para o sistema de saúde do país



TAM

Médicos ativos registrados em Santa Catarina — base imediata de adoção individual gratuita.

SAM

Hospitais de médio/grande porte e cooperativas médicas regionais em SC.

SOM

2–3 hospitais parceiros como piloto, na sequência natural da pré-incubação na Incubintech.

A arquitetura é plugável em qualquer sistema de saúde ocupacional — a mesma base técnica atende outros estados e outras categorias profissionais sob risco semelhante de burnout e estigma.

PRÓXIMO PASSO

Pedimos a vaga na pré-incubação da Incubintech para transformar este protótipo em piloto com um hospital parceiro.

- PoC funcional já demonstra a arquitetura de privacidade ponta a ponta
- Próximos 6–24 meses: validação clínica formal e primeiro piloto institucional
- O sigilo é a regra — e é também a razão pela qual hospitais, médicos e pacientes podem confiar

